PROFESIONAL

EJE 1 · TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

Lista de verificación en endoscopía: factible y útil para identificar riesgos del paciente

Vazquez D., Laudanno O., Moreno C., Lafage M., Pucci B., Aular D., Amaya D.

Servicio de Gastroenterología, Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Universidad de Buenos Aires (UBA)

1 INTRODUCCIÓN

Las listas de verificación (checklists) recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) permitieron reducir la morbimortalidad quirúrgica (Haynes et al., 2009; World Health Organization, 2009). En endoscopía se las propone como estrategia para aumentar la seguridad del paciente (Dubois et al., 2017). La complejidad técnica y las comorbilidades de los pacientes exigen herramientas que aseguren la calidad asistencial, y la experiencia publicada sobre su implementación aún es limitada (Cherciu Harbiyeli et al., 2023). Por ello se implementó una estrategia de seguridad basada en un formulario de enfermería adaptado al Servicio de Gastroenterología.

2 OBJETIVOS

Objetivo general: implementar una lista de verificación de seguridad en los procedimientos endoscópicos del servicio, con el fin de mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Objetivos específicos:

- Estandarizar los pasos previos, intra y post procedimiento.
- Favorecer la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de salud.
- Identificar precozmente factores de riesgo y documentar sistemáticamente las intervenciones.

3 METODOLOGÍA

Diseño: estudio descriptivo y prospectivo.

Ámbito y período: Servicio de Gastroenterología de un hospital universitario de CABA; abril de 2025 a junio de 2026.

Población: 452 pacientes consecutivos sometidos a procedimientos endoscópicos.

Intervención: formulario de enfermería de seguridad, basado en las recomendaciones de la OMS y adaptado al servicio, para verificar los pasos previos, intra y post procedimiento.

Instrumentos y análisis: edad, sexo, tipo de procedimiento, clasificación ASA (American Society of Anesthesiologists, 2020), motivo de estudio, patologías preexistentes, capacidad funcional (Índice de Barthel; 100 puntos = independencia total; Mahoney y Barthel, 1965), obesidad (incluido el uso de agonistas GLP-1) y complicaciones. Análisis descriptivo.

Aspectos éticos: se resguardó la identidad de los pacientes; los datos se presentan agregados, sin identificadores.

4 RESULTADOS

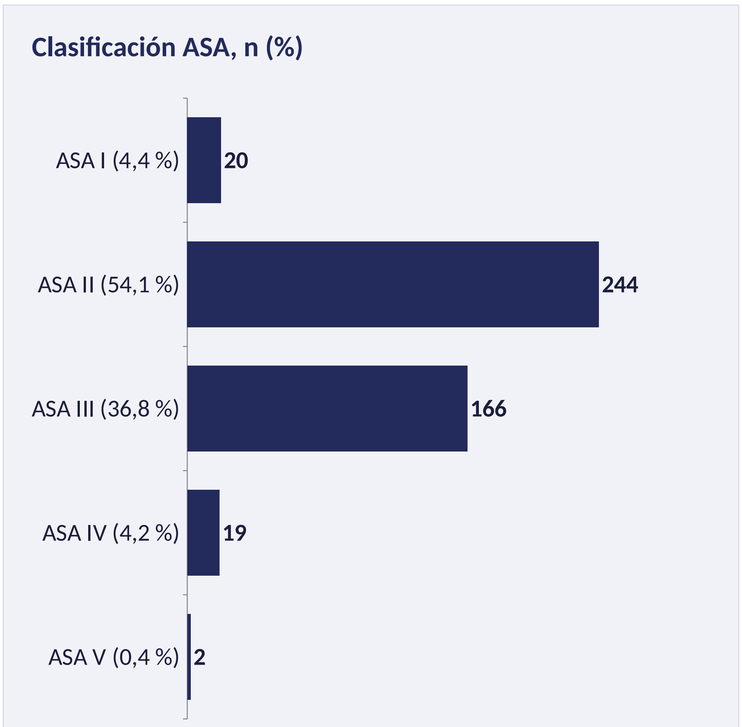


Figura 1. Distribución de los pacientes según la clasificación ASA (n = 451). Fuente: elaboración propia.

11,9 %
de los procedimientos presentó complicaciones (54/452)

25,9 %
de las complicaciones obligó a suspender el procedimiento (14/54)

Se incluyeron 452 pacientes consecutivos: edad promedio 71,5 años; 63,4 % mujeres y 36,6 % varones.

Procedimientos: colonoscopía (VCC) 179 (39,6 %), doble VEDA-VCC 163 (36,1 %), videoendoscopía digestiva alta (VEDA) 99 (21,9 %) y rectoscopía 11 (2,4 %).

Capacidad funcional (Barthel): independencia 42,5 %; dependencia leve 33,4 %, moderada 15,7 %, severa 8,2 % y total 0,4 %.

Obesidad: 97 pacientes (21,5 %); 5 de ellos (5,2 %) refirieron usar agonistas GLP-1.

Complicaciones: hipertensión, hipotensión, desaturación de oxígeno, retención de alimentos en la vía digestiva, laringoespasmo y vómitos.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

La lista de verificación fue factible en 452 pacientes consecutivos y permitió documentar de forma sistemática su riesgo clínico y las complicaciones.

Se cumplió el objetivo de implementar la lista de verificación y se registró de forma sistemática el perfil de riesgo de los pacientes.

Alcances y limitaciones: estudio descriptivo, sin grupo comparador y en un único hospital; no evalúa el impacto sobre la comunicación del equipo ni sobre los eventos adversos. Se requieren estudios comparativos.

6 APORTE A ENFERMERÍA

El formulario de enfermería permite verificar y registrar de forma sistemática los pasos previos, intra y post procedimiento, y detectar a tiempo los factores de riesgo del paciente. Puede adaptarse a otros servicios que realicen procedimientos con riesgo para el paciente.

7 REFERENCIAS

American Society of Anesthesiologists. (2020). *ASA physical status classification system*. https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-asa-physical-status-classification-system

Cherciu Harbiyeli, I. F., Burtea, D. E., Serbanescu, M.-S., Nicolau, C. D., & Saftoiu, A. (2023). Implementation of a customized safety checklist in gastrointestinal endoscopy and the importance of team time out: A dual-center pilot study. *Medicina*, *59*(6), 1160. https://doi.org/10.3390/medicina59061160

Dubois, H., Schmidt, P. T., Creutzfeldt, J., & Bergenmar, M. (2017). Person-centered endoscopy safety checklist: Development, implementation, and evaluation. *World Journal of Gastroenterology*, *23*(48), 8605–8614. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i48.8605

Haynes, A. B., Weiser, T. G., Berry, W. R., Lipsitz, S. R., Breizat, A.-H. S., Dellinger, E. P., Herbosa, T., Joseph, S., Kibatala, P. L., Lapitan, M. C., Merry, A. F., Moorthy, K., Reznick, R. K., Taylor, B., & Gawande, A. A. (2009). A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. *The New England Journal of Medicine*, *360*(5), 491–499. https://doi.org/10.1056/NEJMsa0810119

Mahoney, F. I., & Barthel, D. W. (1965). Functional evaluation: The Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*, *14*, 61–65.

World Health Organization. (2009). *WHO guidelines for safe surgery 2009: Safe surgery saves lives*. WHO.

Contacto: gastroenterologia@lanari.uba.ar